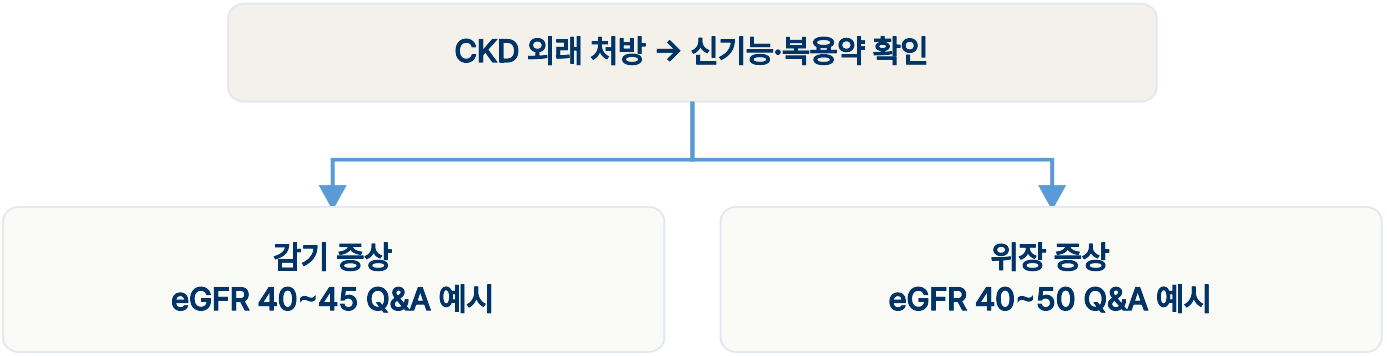
CKD 환자의 감기약·위장약

장재원 연자 Q&A · 제시된 신기능 범위와 처방 맥락을 함께 보기



처방 원칙 · eGFR 40~45 질문의 답변

신기능에 영향이 없는 가장 안전한 약물로 구성하고, 증상이 견딜 만하도록 가능하면 소량 복용하게 교육·처방한다고 답했습니다. 아래는 연자가 제시한 약제와 용량입니다.

감기 증상별 예시 · 연자 Q&A

구분	진료 중 확인할 내용
기침	코푸시럽 20 mL · qd~tid
가래	뮤테란 200 mg · tid
콧물	알레그라 120 mg · qd
코막힘	슈다페드 1T · qd~tid
진통	타이레놀ER 650 mg · qd~tid
인후통	NSAID 가글과 헥사메딘 가글 교대 사용

위장약 · eGFR 40~50 질문의 답변

구분	진료 중 확인할 내용
PPI·케이캡	정상 신기능 환자에 쓰는 상용량.
Rebamipiride·polybutin	정상 신기능 환자에 쓰는 상용량.
거드	제약회사에 문의하도록 답변.

제균 전 병용약 신독성·장정결약 점검

장재원 연자 Q&A의 제균 증례와 본강의 약물 주의점

고령 환자 · 정상 Cr만으로 full dose 판단하지 않기

본강: 노인은 근육량이 감소하여 신실질이 줄어도 Cr이 정상처럼 보일 수 있으므로 약물 투여량을 조심해서 검토합니다.

제균 증례 · 연자 Q&A

신증후군 치료 중 50세 남성, Cr 1.28·cystatin C 0.87·2021 융합공식 eGFR 86, CLO 양성 증례입니다. 혈청 albumin이 정상으로 유지되고 cyclosporine·tacrolimus를 쓰지 않으면 표준 3제(amoxicillin·clarithromycin·PPI) 요법이 적절하다고 답했습니다. 부작용 설명과 추적 관찰을 함께 제시했습니다.

Cyclosporine·tacrolimus 복용 중 · 연자 Q&A

Clarithromycin이 두 약의 농도를 높일 수 있으므로 신장내과 의사와 상의하도록 답했습니다.

본강 · 신독성과 전해질 점검

구분	진료 중 확인할 내용
NSAIDs·COX-2 억제제	신기능 악화에 주의. NSAID는 저나트륨혈증·신증후군·고칼륨혈증·고혈압과도 관련.
이뇨제 등	Thiazide는 저나트륨혈증 주의. 이뇨제·SGLT2 억제제는 신전성 질소혈증에 주의.
신기능별 약물 검토	Aminoglycosides, 방사성 조영제, cisplatinum 등 항암제, digoxin, procainamide, tetracycline, vancomycin 등을 주의 약제로 제시.

대장내시경 장정결 · 본강

구분	진료 중 확인할 내용
금지 조건	GFR <60 mL/min/1.73m²에서 솔린액 오라 등 경구 인산소다 용액 금지.
연자가 제안한 선택	양이 많은 4 L·8 L 하제가 콩팥 영향을 최소화하여 더 안전하다고 설명.